

Saúde do trabalhador em Campos dos Goytacazes: formação histórico-social e perfil das comunicações de acidentes de trabalho entre profissões da saúde, 2018–2025

Resumo: Objetivou-se analisar, à luz da formação histórico-social e econômica de Campos dos Goytacazes (RJ), o perfil das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) vinculadas a empregadores do município entre as profissões da saúde, de 2018 a 2025. Estudo teórico-conceitual, com análise documental e dados secundários: fontes teóricas da Saúde do Trabalhador e da sociologia do trabalho, caracterização municipal (IBGE) e reconstrução integral e auditada dos dados abertos da CAT/INSS (58 arquivos; 3.902.905 registros), com filtro pelo código do município do empregador (330100) e UF, classificação ocupacional por códigos CBO 2002 e validação independente. Identificaram-se 5.066 CATs de empregadores do município, das quais 1.144 (22,6%) de profissões da saúde: 84,4% da enfermagem (70,2% de técnicos e auxiliares) e apenas 1,0% da medicina; predominaram mulheres (85,7%), acidentes típicos (81,9%), ferimentos de dedos e mãos e exposição a material biológico (26,9%); doenças relacionadas ao trabalho somaram 1,0%. A média mensal de registros elevou-se no período crítico da covid-19. O padrão expressa a divisão social e técnica do trabalho em saúde e desigualdades de proteção e de notificação conformadas pela trajetória econômica local, marcada pela transição do açúcar ao petróleo e pela dependência fiscal. Frequências de registro não medem risco; recomenda-se qualificar registros e incorporar denominadores (RAIS/CNES) à vigilância.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Acidentes de Trabalho; Notificação de Acidentes de Trabalho; Pessoal de Saúde; Desenvolvimento Regional.

O trabalho, entendido como processo social, econômico, político e técnico — e não como mero local de exposição a riscos —, é historicamente determinado: da disciplinarização fabril inaugurada pela Revolução Industrial às reconfigurações contemporâneas, o modo de organizar a produção modela corpos, tempos e adoecimentos (OLIVEIRA, 2004). As teses do “fim do trabalho” não se sustentam: o que houve foi deslocamento e ampliação da classe trabalhadora para os serviços, setor em que hoje se concentram precarização, terceirização e intensificação (LOURENÇO, 2012; ANTUNES, 2018). No Brasil, o campo da Saúde do Trabalhador constituiu-se, a partir da crítica à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, como leitura da determinação social do processo saúde-doença ancorada no processo de trabalho e no protagonismo dos trabalhadores (MENDES; DIAS, 1991). No setor saúde, esse referencial ganha densidade: o trabalho em saúde produz cuidado, mas se realiza sob divisão social e técnica do trabalho, relações de poder entre categorias, cargas e desgaste, num contexto de reorganização gerencial-flexível dos serviços em que parcela expressiva dos vínculos do SUS — estimada entre 30% e 50% — carece de proteção plena de direitos (CECILIO; LACAZ, 2012). Este artigo analisa, à luz da formação histórico-social e econômica de Campos dos Goytacazes (RJ), o perfil das CATs vinculadas a empregadores do município entre as diferentes profissões da saúde, de 2018 a 2025.

Campos dos Goytacazes, maior município fluminense em extensão (4.032,5 km²; 483.540 habitantes no Censo 2022), formou-se sobre a economia açucareira colonial — engenhos e depois usinas assentados em concentração fundiária e no trabalho escravizado — e conheceu, ao longo do século XX, a decadência da agroindústria canavieira, substituída, desde os anos 1980-1990, pela centralidade da exploração de petróleo da Bacia de Campos e das rendas petrolíferas (SILVA; HASENCLEVER, 2019). Os dados oficiais evidenciam uma economia oscilante e dependente: o PIB a preços correntes saltou a R\$ 58,4 bilhões em 2013, caiu a R\$ 23,9 bilhões em 2020 e retornou a R\$ 43,0 bilhões em 2023; a indústria (dominada pela atividade extrativa) respondeu por 66,4% do valor adicionado em 2013 e 40,8% em 2020, enquanto a agropecuária — apesar da identidade “agro” do discurso local — representou apenas 1,0% em 2021, com a produção de cana caindo de 4,28 milhões de toneladas (2005) para 1,29 milhão (2023) (IBGE, 2026). Silva e Hasenclever (2019) demonstram que o ciclo do petróleo (1999-2014) elevou arrecadação e PIB sem diversificação produtiva correspondente nem desenvolvimento social equivalente — riqueza fiscal convivendo com desigualdade e emprego concentrado em serviços de baixa remuneração. Essa contradição alcança diretamente a saúde: o financiamento municipal acompanhou as flutuações das rendas de indenizações petrolíferas entre 2009 e 2020, fragilizando a gestão da rede (MARTINS; HASENCLEVER; MIRANDA, 2024). Nesse mercado de trabalho, os serviços de saúde — polo regional de referência do Norte Fluminense — constituem importante espaço de assalariamento, sobretudo feminino, estratificado por hierarquias de renda, prestígio e fechamento social entre profissões, na acepção weberiana de classe e estamento (LEMOS, 2012).

Método. Estudo teórico-conceitual e documental com apoio de dados secundários. A base empírica foi reconstruída integralmente a partir dos 58 arquivos brutos dos dados abertos da CAT/INSS (competências de jul./2018 a dez./2025; 3.902.905 linhas) (BRASIL, 2026a), importados por posição ante quatro esquemas estruturais com cabeçalhos duplicados (CBO, CID-10, CNAE, “Data Acidente”), codificação detectada por arquivo e distinção estrita entre o mês de referência (coluna 2) e a data completa do acidente, usada nas análises temporais. O filtro municipal exigiu, simultaneamente, código do município do empregador igual a 330100 (extraído antes do hífen) e UF do empregador Rio de Janeiro, excluindo-se homônimos (Campos Novos, Campos do Jordão, Campos de Júlio, São José dos Campos etc.) e 12 registros com UF divergente. Removeram-se 537 duplicidades exatas entre arquivos de cobertura sobreposta (hash SHA-256 da linha bruta). A classificação ocupacional baseou-se nos códigos CBO 2002 de seis dígitos, com dicionário mestre auditado dos 459 códigos observados e três níveis: universo principal das profissões da saúde (medicina, enfermagem, odontologia/saúde bucal, farmácia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, técnicos e auxiliares de diagnóstico e laboratório, agentes comunitários e afins, instrumentação cirúrgica); profissões multiprofissionais intersetoriais (psicologia, serviço social, educação física, biologia), analisadas à parte com sensibilidade restrita a empregadores de CNAE 86/87; e trabalhadores de apoio em estabelecimentos de saúde, jamais somados às profissões da saúde. Registros sem CBO válido (184; 3,6%) foram mantidos em categoria própria. Denominadores de força de trabalho foram extraídos do CNES/DataSUS — profissionais (indivíduos) por ocupação, em dezembro de cada ano, no município (BRASIL, 2026b) —, mas, por incluírem vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica não cobertos pela CAT, sustentam apenas razões exploratórias de densidade de comunicação, e não incidência; no mais, apresentam-se frequências e proporções dentro do conjunto de CATs, com agregação de células $n < 5$. Os totais foram reproduzidos por rotina independente, com convergência integral; análises de sensibilidade abrangeram exclusão de 2025 (parcial, até out.), meses equivalentes, exclusão de trajeto, somente típicos e universo restrito a CNAE 86/87.

Das 5.066 CATs de empregadores de Campos, 1.144 (22,6%) referem-se ao universo principal das profissões da saúde — proporção que, por si, indica o peso do polo assistencial no emprego formal celetista local. A distribuição interna (Tabela 2) é fortemente assimétrica: a enfermagem concentra 84,4% dos registros (técnicos e auxiliares, 70,2%; enfermeiros, 14,2%), seguida de técnicos e auxiliares de diagnóstico e laboratório (6,8%) e fisioterapia (2,6%); a medicina soma 1,0%. Predominam mulheres (85,7%), idade mediana de 36 anos, acidentes típicos (81,9%; trajeto, 17,1%), ferimentos de punho e mãos (CID S61, 25,1%; “dedo” como parte atingida, 43,9%) e contato/exposição a doenças transmissíveis (Z20, 21,9%); agentes infecciosos e produtos biológicos respondem por 26,9% dos agentes causadores. Quase a totalidade dos empregadores pertence às divisões CNAE 86/87 (95,4%), com franca dominância hospitalar (classe 8610: 76,8%) — quadro coerente com a função de polo regional. O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia entre acidente e emissão; registrou-se um óbito. Registros de “doença” somaram apenas 1,0%, mesmo atravessando a pandemia — indício robusto de subnotificação das doenças relacionadas ao trabalho.

A leitura teórica desses achados recusa a redução do problema a uma lista de riscos biológicos ou ergonômicos. A concentração dos registros na base técnica da enfermagem expressa a divisão social e técnica do trabalho em saúde: a execução manual, contínua e corporal do cuidado — punção, medicação, manipulação de perfurocortantes, mobilização de pacientes — é delegada às categorias femininas de menor renda e prestígio, submetidas a sobrecarga, dupla jornada e intensificação, das quais deriva o desgaste (CECILIO; LACAZ, 2012; ANTUNES, 2018). Já a quase invisibilidade da medicina (12 CATs em oito anos) não autoriza concluir menor exposição: reflete, antes, a inserção médica por vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, à margem do emprego celetista coberto pela CAT — desigualdade de proteção e de reconhecimento institucional que reitera, no plano previdenciário, a estratificação de classe e status entre as profissões (LEMONS, 2012). Pela mesma razão, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, majoritariamente vinculados à administração municipal, praticamente inexistem na base (14 registros de ACS e afins; nenhum ACE), sem que se possa inferir ausência de adoecimento. A elevação da média mensal de registros no período crítico da covid-19 (10,7 em jan./2018-fev./2020; 14,5 em mar./2020-dez./2021; 11,9 após) e o peso das exposições biológicas são compatíveis com a sobrecarga pandêmica descrita para os trabalhadores

da saúde — condições de trabalho “à deriva”, com déficit de proteção e reconhecimento (VEDOVATO et al., 2021) —, mas oscilações de cobertura da própria fonte impedem qualquer atribuição causal (Figura 1).

Os dados permitem afirmar a estrutura interna das comunicações registradas — quem aparece, com quais lesões, em quais vínculos e estabelecimentos —, e não permitem estimar incidência, prevalência ou risco ocupacional: diferenças entre categorias podem refletir tamanho das forças de trabalho, composição e formalização dos vínculos, terceirização, cobertura previdenciária, cultura institucional e subnotificação diferencial. A robustez interna é alta: a predominância da enfermagem e a hierarquia das categorias mantêm-se em todas as análises de sensibilidade — exclusão de 2025, meses jan.–out., exclusão de trajeto, somente típicos e restrição a CNAE 86/87 (participação da enfermagem entre 84,4% e 86,3%). Denominadores reais do CNES/DataSUS — profissionais por ocupação em dezembro de cada ano, de 9.803 (2018) a 13.275 (2025) no município (BRASIL, 2026b) — permitem uma razão exploratória de densidade de comunicação, jamais de incidência, pois o CNES inclui vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, fora da cobertura da CAT: nos anos de cobertura integral (2019–2021 e 2023), houve 29,5 a 43,5 CATs por 1.000 técnicos e auxiliares de enfermagem ao ano, 19,4 a 32,7 por 1.000 enfermeiros e, na medicina, no máximo 3,6 (2019; demais anos suprimidos por $n < 5$) — gradiente que reforça a leitura de proteção e notificação desiguais entre as categorias. Vínculos formais da RAIS/eSocial por CBO, município e ano permanecem como denominador prioritário para indicadores padronizados, condicionados à verificação de compatibilidade entre numerador e denominador.

Considerações finais. Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e a gestão municipal, os resultados indicam prioridades concretas: proteger a base técnica da enfermagem — núcleo do cuidado e dos registros —, com ênfase em perfurocortantes e exposição biológica; enfrentar a subnotificação de doenças relacionadas ao trabalho e a invisibilidade de estatutários, terceirizados e informais, articulando CAT, RAIS, CNES e as notificações do SUS; qualificar o preenchimento (3,6% dos registros sem CBO válido, concentrados em 2021–2023); e planejar a rede — cuja sustentação financeira oscila com as rendas petrolíferas (MARTINS; HASENCLEVER; MIRANDA, 2024) — reconhecendo que a proteção dos que cuidam é condição do cuidado. Limitações: a CAT capta comunicações, não a totalidade dos acidentes; cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo informais, autônomos e estatutários; não há denominadores compatíveis para incidência — as razões com o CNES são exploratórias, pois o denominador inclui vínculos não celetistas —; a cobertura da fonte é parcial em 2018 (competências desde jul.), irregular em 2022, atípica em set.-dez./2024 e incompleta em 2025 (até out.), o que restringe comparações anuais; registros sem CBO podem subestimar profissões da saúde em 2021–2023; e o desenho descritivo-documental não permite inferência causal.

Tabela 1 – Campos dos Goytacazes (RJ): síntese da formação econômica e social

Indicador	Valores	Fonte (IBGE/SIDRA)
População residente (2022); área; densidade	483.540 hab.; 4.032,5 km ² ; 119,9 hab./km ²	Censo 2022 (tab. 4714)
PIB a preços correntes	R\$ 58,4 bi (2013); R\$ 23,9 bi (2020); R\$ 43,0 bi (2023)	PIB dos Municípios (tab. 5938)
Participação da indústria (extrativa) no valor adicionado	66,4% (2013); 40,8% (2020)	PIB dos Municípios (tab. 5938)
Participação da agropecuária no valor adicionado (2021)	1,0%	PIB dos Municípios (tab. 5938)
Cana-de-açúcar: quantidade produzida	4,28 mi t (2005); 1,29 mi t (2023)	PAM (tab. 1612)

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2026); valores correntes, sem deflacionamento; interpretação histórica conforme Silva e Hasenclever (2019).

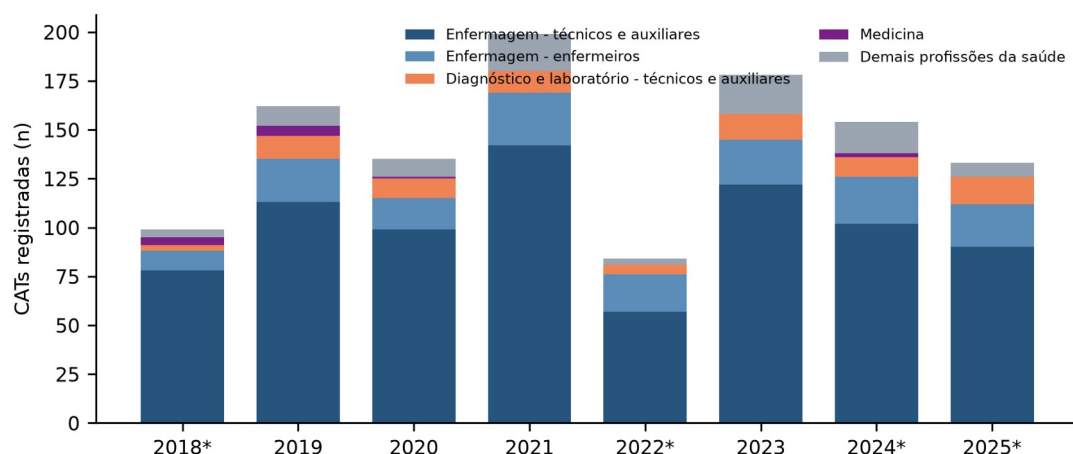


Figura 1 – CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144) vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), por ano do acidente e categoria profissional, 2018–2025. Unidade: registros. Fonte: elaboração própria a partir de BRASIL (2026a). *Cobertura parcial/irregular da fonte (2018: competências desde jul.; 2022: carga irregular; 2024: set.–dez. atípicos; 2025: até out.). Frequências de comunicação, não taxas de acidente.

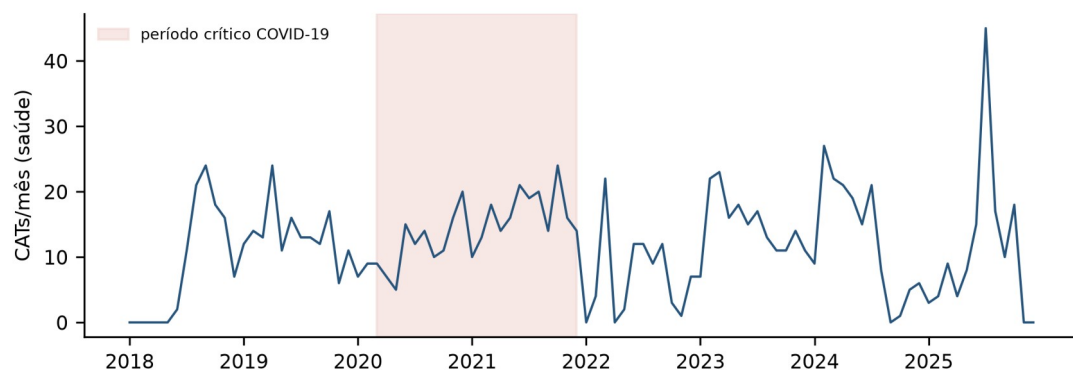


Figura 2 – Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (universo principal, n = 1.144), empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), jan./2018–dez./2025, com destaque para o período crítico da covid-19 (mar./2020–dez./2021). Unidade: registros/mês. Fonte: elaboração própria a partir de BRASIL (2026a). As oscilações também refletem a cobertura da fonte (ver notas da Figura 1); médias mensais: 10,7 (pré-pandemia), 14,5 (período crítico) e 11,9 (pós-crítico).

Tabela 2 – Características das CATs das profissões da saúde, empregadores de Campos dos Goytacazes (RJ), 2018–2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)
Enfermagem – técnicos e auxiliares	803 (70,2)
Enfermagem – enfermeiros	163 (14,2)
Diagnóstico e laboratório – técnicos e auxiliares	78 (6,8)
Fisioterapia	30 (2,6)
Farmácia – técnicos e auxiliares	20 (1,7)
Agentes comunitários de saúde e afins	14 (1,2)
Medicina	12 (1,0)
Demais categorias (farmácia, nutrição, odontologia/saúde bucal, fonoaudiologia, instrumentação; n<5 agregados)	24 (2,1)
Sexo feminino	980 (85,7)
Acidente típico trajeto doença	937 (81,9) 196 (17,1) 11 (1,0)
Parte atingida: dedo	502 (43,9)
Agente causador biológico/infeccioso	308 (26,9)
CID-10: S61 (ferimento punho/mão) Z20 (exposição a doenças transmissíveis)	287 (25,1) 250 (21,9)
Empregador em CNAE 86/87 (dos quais classe 8610 – hospitalar)	1.091 (95,4) 879 (76,8)
CAT emitida pelo empregador; mediana acidente→emissão = 1 dia	1.110 (97,0)

Fonte: elaboração própria a partir de BRASIL (2026a). Idade mediana: 36 anos. Percentuais sobre o total de registros do universo principal; sexo ignorado em 4 registros; um óbito registrado.

Referências

ANTUNES, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social. Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT: dados abertos, competências jul. 2018–dez. 2025. Brasília, DF: INSS, 2026a. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/inss-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat>. Acesso em: 18 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. CNES – Recursos Humanos – Profissionais – Indivíduos – segundo CBO 2002 – Rio de Janeiro. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b. TabNet. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br>. Acesso em: 18 jul. 2026.

CECILIO, L. C. O.; LACAZ, F. A. C. O trabalho em saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2012.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: Censo Demográfico 2022 (tabela 4714); Produto Interno Bruto dos Municípios (tabela 5938); Produção Agrícola Municipal (tabela 1612). Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Acesso em: 18 jul. 2026.

LEMONS, M. R. Estratificação social na teoria de Max Weber: considerações em torno do tema. *Revista Iluminart*, Sertãozinho, ano 4, n. 9, p. 113-128, nov. 2012.

LOURENÇO, G. G. O fim do fim do trabalho: uma crítica à chamada sociedade pós-industrial e sua relação com os movimentos de trabalhadores. *Primeiros Estudos*, São Paulo, n. 3, p. 104-121, 2012.

MARTINS, S.; HASENCLEVER, L.; MIRANDA, C. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. DOI: 10.12957/cdf.2024.87352.

MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, 1991. DOI: 10.1590/S0034-89101991000500003.

OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. *Caminhos de Geografia*, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 84-96, fev. 2004.

SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes – 1999/2014. *Desenvolvimento em Questão*, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. DOI: 10.21527/2237-6453.2019.46.314-332.

VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 46, e1, 2021. DOI: 10.1590/2317-6369000028520.